内科含诊断 心包疾病 ★★★（0~3题）

- 急性纤维蛋白性心包炎（如急性非特异性心包炎）
  - 1~3 周感染病史，随后胸痛（锐痛）
  - 心包摩擦音（胸骨左缘 3~4 肋间搔 / 抓刮音、屏气后仍有）
  - 心界不大或稍大
  - 可能可能最可能（2019、2020、2026）
- 渗出性心包炎→心包积液→心脏压塞
  - 可能可能最可能（2014、2017、2022、2024）
  - 随积液量增多心包摩擦音、胸痛可消失，呼吸困难突出
  - 心界向两侧扩大、奇脉、脉压↓、心率↑、心尖搏动减弱（2009、2018）
  - 体循环回流障碍：颈静脉怒张、肝颈静脉回流征、双下肢水肿、胸腹水
  - 心脏压塞 Beck 三联征：心音低弱遥远、低血压、颈静脉怒张“动脉压低、静脉压高”（2007、2026）
  - Kussmaul 征（吸气时颈静脉扩张更明显）、Ewart 征（左肩胛下浊音 + 语颤增强 + 异常支气管呼吸音）
- 检查
  - 超声心动图：首选（2014、2017、2024）
  - 心包穿刺
    - 确诊积液性质（病因诊断）的金标准（2011）
      - 类似胸腔积液相关疾病
      - 血性心包积液多考虑结核、肿瘤、急非特（淋巴细胞为主）“血淋淋”
    - 缓解心脏压塞症状（2017）
  - X 线：心包积液呈烧瓶心（心影向两侧显著增大）、特别是肺野清晰（鉴别左心功能不全）